



- Q9 : L'exploration standard de la pyramide nasale se fait classiquement par :
- ☒ A. L'incidence de Harsanyi ;
 - ☐ B. L'incidence de Waters bouche fermée ;
 - ☐ C. L'incidence du profil strict ;
 - ☐ D. L'incidence de Rittz.
- Q10 : En incidence de Gasser, le rayon directeur est dirigé :
- ☐ A. Verticalement de haut en bas ;
 - ☐ B. Horizontalement perpendiculaire au diaphragme ;
 - ☐ C. Obliquement vers le défilé maxillaire ;
 - ☐ D. Tangentiellement aux os propres du nez.
- Q11 : Une mauvaise ouverture de la bouche, en incidence de Gasser, entraîne principalement :
- ☐ A. Une surexposition du cliché ;
 - ☐ B. Une superposition des structures osseuses ;
 - ☐ C. Une rotation de la tête ;
 - ☐ D. Une mauvaise visualisation du défilé maxillaire.
- Q12 : Le cliché de coccyx de face est insuffisant seul pour :
- ☐ A. Détecter une fracture déplacée ;
 - ☐ B. Évaluer une anomalie morphologique ;
 - ☐ C. Apprécier une mobilité anormale du coccyx ;
 - ☐ D. Visualiser une calcification.
- Q13 : Un cliché de face de l'aseplat répond aux critères de réussite lorsque :
- ☐ A. La scapule est dégagée de la superposition costale au maximum ;
 - ☐ B. La tête humérale est parfaitement centrée ;
 - ☐ C. Le rachis dorsal est visible ;
 - ☐ D. Les deux épaules sont symétriques.
- Q14 : L'exploration radiologique du défilé acromio-claviculaire permet principalement :
- ☐ A. L'étude de la glène ;
 - ☐ B. La recherche d'un pincement ou d'ostéophytes acromio-claviculaires ;
 - ☐ C. L'exploration de la tête humérale ;
 - ☐ D. L'analyse de la coiffe des rotateurs.
- Q15 : Lors de l'incidence de Lamy, le bras exploré est :
- ☐ A. Le long du corps ;
 - ☐ B. En abduction maximale ;
 - ☐ C. En légère abduction avec coude fléchi ;
 - ☒ D. Derrière le dos.
- Q16 : Pour l'exploration de l'apophyse coronoïde, la position correcte de l'avant-bras est :
- ☐ A. Supination ;
 - ☐ B. Pronations alternées ;
 - ☐ C. Position neutre ;
 - ☐ D. Rotation externe.
- Q17 : Pour une incidence 3/4 alaire, le patient est installé :
- ☐ A. En décubitus dorsal, bassin de face ;
 - ☐ B. En décubitus dorsal, rotation de 45° du côté sain ;
 - ☒ C. En décubitus dorsal, rotation de 45° du côté exploré ;
 - ☐ D. En décubitus ventral.
- Q18 : Parmi les critères de réussite d'un cliché 3/4 obturateur, il y a :
- ☐ A. L'aile iliaque est dégagée ;
 - ☐ B. Le trou obturateur du côté exploré est bien ouvert ;
 - ☐ C. Les deux trous obturateurs sont visibles ;
 - ☐ D. Le rachis lombaire est centré.
- Q19 : Sur l'incidence oblique du rachis lombaire, les corrélations anatomo-radiologiques des différentes parties du « petit chien de la chapelle » sont les suivantes :
- ☐ A. L'œil correspond à l'apophyse transverse ;
 - ☐ B. L'oreille apophyse correspond à l'articulaire supérieure ;
 - ☐ C. Le cou correspond à l'isthme ;
 - ☐ D. Le corps correspond à l'apophyse articulaire inférieure.
- En ASP, le signe radiologique le plus évocateur d'une occlusion mécanique de la grêle correspond à :
- ☐ A. La présence de niveaux hydro-aériques périphériques ;
 - ☐ B. La présence de niveaux hydro-aériques centraux multiples disposés en cadre ;
 - ☐ C. Une distension colique isolée ;
 - ☐ D. Une absence totale de gaz digestif.
- En mammographie, les principaux intérêts du cliché localisé consistent à :
- ☐ A. Bien visualiser les foyers de microcalcifications ;
 - ☐ B. Limiter les superpositions en refoulant les tissus voisins ;
 - ☐ C. Préciser les contours d'une opacité ;
 - ☐ D. Améliorer la définition globale des contours.

- Q22 : Avant la réalisation d'une TDM du crâne, la préparation systématique obligatoire consiste à :
- Instaurer un jeûne strict de 6 heures ;
 - Procéder au retrait de tous les objets métalliques (bijoux, piercings, prothèses dentaires amovibles) ;
 - Réaliser un lavement évacuateur ;
 - Effectuer un rasage complet de la tête.
- Q23 : Les reconstructions tridimensionnelles (3D) en TDM du crâne sont particulièrement utiles dans le contexte suivant :
- Suspicion d'AVC ischémique ;
 - Traumatismes crânio-faciaux avec fractures complexes ;
 - Recherche d'hydrocéphalie ;
 - Bilan pré-opératoire de tumeur cérébrale.
- Q24 : En cas d'injection d'un produit de contraste iodé lors d'une TDM cérébrale, la mesure de préparation indispensable est :
- La vérification de la fonction rénale ;
 - L'administration systématique d'antihistaminiques ;
 - Le jeûne de 12 heures ;
 - La pose d'une sonde urinaire.
- Q25 : Avant l'entrée d'un patient en salle d'IRM, l'objet qui doit absolument être retiré est :
- Les lunettes en plastique ;
 - La carte bancaire (puce magnétique) ;
 - Les bouches d'oreilles en mousse ;
 - Toutes les propositions sont fausses.
- Q26 : En cas d'injection de gadolinium en IRM, la vérification essentielle à réaliser concerne :
- La fonction rénale avec un DFG (Débit de Filtration Glomérulaire) généralement supérieur à 30 mL/min ;
 - La glycémie capillaire du patient ;
 - La tension artérielle uniquement ;
 - Toutes les propositions sont fausses.
- Q27 : Pour gérer la claustrophobie d'un patient lors d'un examen IRM, la mesure psychologique prioritaire repose sur :
- Une explication détaillée de l'examen associée à la mise à disposition d'une poire d'urgence ;
 - Une administration systématique de sédatifs avant l'examen ;
 - La réalisation de l'examen en position debout ;
 - Une augmentation de l'intensité du champ magnétique.
- Q28 : Le rôle principal des antennes (coils) en IRM consiste à :
- Générer le champ magnétique principal de l'appareil ;
 - Améliorer le rapport signal sur bruit en recevant le signal localement ;
 - Assurer le refroidissement du système IRM ;
 - Réduire les artefacts.
- Q29 : La scintigraphie osseuse statique correspond à des images acquises :
- Immédiatement après l'injection ;
 - 5 à 10 minutes après l'injection ;
 - 2 à 4 heures après l'injection ;
 - 24 heures après l'injection.
- Q30 : En scintigraphie osseuse, une hyperfixation traduite généralement :
- Une diminution de l'activité osseuse ;
 - Une activité osseuse augmentée ;
 - Une absence de vascularisation ;
 - Une nécrose systématique.



Concours de recrutement des infirmiers et des techniciens de santé
session du 18 janvier 2026

Durée : 02h00
Coefficient : 3

Cadre : Techniciens de santé
Spécialité : Radiologie

2^{ème} épreuve

Instructions pour répondre sur la grille de réponses

- La grille de réponse est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponse par candidat) ;
- Pour répondre aux 30 questions, cocher la grille de réponses la case correspondante à la ou les bonnes réponses ;
- en mettant une croix ;
- Utiliser un stylo à bille bleu ou noir ;
- Ne pas utiliser de correcteur (blanco).

Cochez la ou les bonnes réponses

Q1 : La mission principale du technicien de radiologie au sein d'un service d'imagerie consiste à :

- A. Garantir la radioprotection du patient et du personnel lors des examens ;
- B. Prescrire les examens d'imagerie ;
- C. Réaliser les examens d'imagerie médicale sur prescription médicale ;
- D. Interpréter les images radiologiques.

Q2 : Selon les principes de radioprotection, le technicien de radiologie doit :

- A. Utiliser la dose maximale pour une meilleure image ;
- B. Appliquer le principe ALARA ;
- C. Adapter les paramètres techniques à la morphologie du patient ;
- D. Utiliser les moyens de protection individuelle et collective disponibles.

Q3 : Pour assurer sa propre sécurité, le technicien de radiologie doit :

- A. Se placer dans l'axe du faisceau ;
- B. Utiliser les équipements de protection individuelle ;
- C. Ignorer les règles de distance ;
- D. Désactiver les dispositifs de sécurité.

Q4 : Le technicien de radiologie est chargé de :

- A. Réparer les pannes majeures ;
- B. Assurer l'entretien de premier niveau et signaler toute anomalie ;
- C. Modifier les réglages sans protocole ;
- D. Valider les contrôles qualité réglementaires.

Q5 : La collimation a pour objectif principal de :

- A. Augmenter la dose délivrée ;
- B. Améliorer le contraste et réduire l'irradiation inutile ;
- C. Élargir le champ d'examen ;
- D. Supprimer les artefacts.

Q6 : L'augmentation de la distance foyer-détecteur permet :

- A. Une augmentation du flou géométrique ;
- B. Une diminution du flou géométrique ;
- C. Une augmentation de la dose patient ;
- D. Une perte de netteté.

Q7 : Une rotation du patient non corrigée entraîne principalement :

- A. Une surexposition ;
- B. Une distorsion et une superposition des structures ;
- C. Une augmentation du contraste ;
- D. Une asymétrie des structures anatomiques projetées.

Q8 : L'incidence de Mahoney est principalement indiquée pour l'exploration :

- A. Des sinus frontaux ;
- B. Des os propres du nez ;
- C. Du défilé maxillaire postérieur ;
- D. Des orbites en incidence axiale.

Q9 : L'exploration standard de la pyramide nasale se fait classiquement par :

- A. L'incidence de Blumens
- B. L'incidence de Waters bouche fermée
- C. L'incidence de profil strict
- D. L'incidence de Viers

Q10 : En incidence de Gossert, le rayon directeur est dirigé :

- A. Verticalement de haut en bas
- B. Horizontalement perpendiculaire au détecteur
- C. Obliquement vers le défilé maxillaire
- D. Tangentiellement aux os propres du nez

Q11 : Une mauvaise ouverture de la bouche, en incidence de Gossert, entraîne principalement :

- A. Une surexposition du cliché
- B. Une superposition des structures osseuses
- C. Une rotation de la tête
- D. Une mauvaise visualisation du défilé maxillaire

Q12 : Le cliché de crany de face est insuffisant seul pour :

- A. Détecter une fracture déplaçée
- B. Évaluer une anomalie morphologique
- C. Apprécier une mobilité normale du crany
- D. Visualiser une calcification

Q13 : Un cliché de face de l'omoplate répond aux critères de réussite lorsque :

- A. La scapula est dégagée de la superposition costale au maximum
- B. La tête humérale est parfaitement centrée
- C. Le rachis dorsal est visible
- D. Les deux épaules sont symétriques

Q14 : L'exploration radiologique du défilé acromio-claviculaire permet principalement :

- A. L'étude de la glène
- B. La recherche d'un placement des d'ostéophytes acromio-claviculaires
- C. L'exploration de la tête humérale
- D. L'analyse de la coiffe des rotateurs

Q15 : Lors de l'incidence de Lamy, le bras exploré est :

- A. Le long du corps
- B. En abduction maximale
- C. En légère abduction avec coude fléchi
- D. Derrière le dos

Q16 : Pour l'exploration de l'apophyse coracoïdale, la position correcte de l'avant-bras est :

- A. Supination
- B. Pronation alternée
- C. Position neutre
- D. Rotation externe

Q17 : Pour une incidence 3/4 alaire, le patient est installé :

- A. En décubitus dorsal, bassin de face
- B. En décubitus dorsal, rotation de 45° du côté sain
- C. En décubitus dorsal, rotation de 45° du côté exploré
- D. En décubitus ventral

Q18 : Parmi les critères de réussite d'un cliché 3/4 obturateur, il y a :

- A. L'aile iliaque est dégagée
- B. Le trou obturateur du côté exploré est bien ouvert
- C. Les deux trous obturateurs sont visibles
- D. Le rachis lombaire est centré

Q19 : Sur l'incidence oblique du rachis lombaire, les corrélations anatomo-radiologiques des différentes parties de «
petit chien de la chapelle » sont les suivantes :

- A. L'œil correspond à l'apophyse transverse
- B. L'oreille apophyse correspond à l'articulaire supérieure
- C. Le cou correspond à l'isthme
- D. Le corps correspond à l'apophyse articulaire inférieure

Q20 : En ASP, le signe radiologique le plus évocateur d'une occlusion mécanique de la grille correspond à :

- A. La présence de niveaux hydro-aériques périphériques
- B. La présence de niveaux hydro-aériques centraux multiples disposés en cadre
- C. Une distension colique isolée
- D. Une absence totale de gaz digestif

Q21 : En mammographie, les principaux intérêts du cliché localisé consistent à :

- A. Bien visualiser les foyers de microcalcifications
- B. Limiter les superpositions en refoulant les tissus voisins
- C. Préciser les contours d'une opacité
- D. Améliorer la définition globale des contours